

STT-Verordnung

Fiktive Patientendaten - ausschließlich für Ausbildung/Simulation Patient/in: Manfred Leitner geb.: 11.11.1958 ID: ST-REK-2025-02
FALL-ID: FALL-REKTUM-BL-02

Datum der Untersuchung:

23.09.2025

Tumornachsorgekalender-Nr:

ausgestellt am:

23.09.2025

Überweiser:

MVZ Gastroenterologie - Musterstadt

Primärdiagnose:

Primärdiagnose: (Datum)	09/2025
Primärtumor:	C20 - Bösartige Neubildung des Rektums, diagnostiziert 23.09.2025 (aktiv)
Histologie des Primärtumors:	Mäßig differenziertes Adenokarzinom
TNM bei Erstdiagnose:	cT3 cN2 cM0
aktuelle Lokalisation: (z.B. Metastase/Rezidiv)	3-9 cm ab ano
TNM-Stadium:	

THERAPIEVERLAUF:

(Zeitraum, Schema + Zyklen bzw. Dosis bei Radiatio)

Über circa 1,5 Jahre blutende rektale Auffälligkeit, zuletzt zunehmende Schmerzen und AZ-Reduktion mit Gewichtsabnahme 10-15 kg. August 2025 ärztliche Vorstellung mit Erstdiagnose des Tumors. Aktuell Vorstellung zur neoadjuvanten Therapie. Nach Aufklärung neoadjuvante Therapie versus TNT-Konzept; Wunsch zur neoadjuvanten Therapie mit OP.

ALLGEMEINANAMNESE:

(Familienanamnese, Risikofaktoren, Vorerkrankungen z. B. Cor/Pulmo, Stoffwechsel, Kollagenosen, Operationen, usw.)

Patient verheiratet, 2 Kinder, Rentner seit 2020, zuvor Sprengmeister. Nebendiagnosen: arterielle Hypertonie und Anämie.

Allergien: ☐ ja ☒ neinSchrittmacher: ☐ ja ☒ neinPort/PEG: ☐ ja ☒ neinBetreuung: ☐ ja ☒ nein

TUMORANAMNESE/aktuelle Beschwerden:

Patient hat zuletzt deutlich Gewicht abgenommen, fühlt sich deutlich müde und schneller körperlich erschöpft, rektale Blutungen bei Stuhlgang zuletzt etwas regredient. Keine größeren Defäkationsschmerzen, keine Inkontinenz.

Bestrahlungsverordnung

Fiktive Patientendaten - ausschließlich für Ausbildung/Simulation Patient/in: Manfred Leitner geb.: 11.11.1958 ID: ST-REK-2025-02
FALL-ID: FALL-REKTUM-BL-02

AKTUELLER STATUS:

Karnofsky-Index:

70% - arbeitsfähig, jedoch selbstständig im Alltag.
(Karnofsky)

Größe:

173 cm

Gewicht:

ca. 66

Reduzierte Belastbarkeit bei Gewichtsverlust; orientiert, selbstversorgend, keine akuten neurologischen Defizite.

BESTRAHLUNGSVERORDNUNG:

Begründung der Strahlentherapie - Indikation:

Rektumkarzinom inklusive zugehörigem Lymphabflussgebiet
1,8 Gy bis 50,4 Gy

☒ kurativ☐ palliativ☐ gutartig

Simultane Systemtherapie:

☐ nein; ☒ ja, 5-FU (1000 mg/m² Körperoberfläche) in der 1. und 5. Behandlungswoche

Vorbestrahlung (wann/Lokalisation/Dosis):

☐ nein; ☒ ja, im Bereich der Wange rechts als Jugendlicher; Unterlagen nicht verfügbar, vermutlich einmalige Bestrahlung bei Ulkus

Kontakt SozDienst besprochen/Infoblatt ausgehändigt

☒ ja

ausgebender Arzt:

Dr. Miriam Keller

auswärtige Bildgebung:

eingelesen: ☐ ja

Bestrahlungsgerät:

☐ L1☒ L2☐ L3☐ AL/IntraBeam

Termine:

Planungs-CT / Maske / Markierung:

02.10.2025 13:00 Uhr, anschließend Rektoskopie

Ersteinstellung:

13.10.2025 09:15 Uhr

Labor vor Chemo:

Tagesklinik:

Station:

13.10.2025

Sonstiges:

Datum: 23.09.2025

erstellender Arzt:

Dr. Jonas Berger

Datum: 23.09.2025

F-/O-Arzt:

Dr. Lara Steiner

CT-Anforderung

Fiktive Patientendaten - ausschließlich für Ausbildung/Simulation Patient/in: Manfred Leitner geb.: 11.11.1958 ID: ST-REK-2025-02
FALL-ID: FALL-REKTUM-BL-02

CT-Anordnung vom: 23.09.2025

Anordnender Arzt: Dr. Jonas Berger

DIAGNOSE: Primär C20 - Bösartige Neubildung des Rektums, diagnostiziert 23.09.2025 (aktiv)

Behandlungsindikation:

curativ

LAGERUNGS- UND SCANVORGABE: REGION:

☐ Schädel ☐ Hals ☐ Thorax ☐ Abdomen ☒ Becken ☐ 4D-Atemstudie ☐ DIBH

☐ Spezielle Anforderung Region:

☐ bei Erreichen einer GHD von

Gy

☐ am:

☐ Extremitäten:

☐ Ganzkörper-CT:

☐ bitte Arzt hinzurufen

(Soll ein Flap aufgelegt werden, z. B. Basaliom Kopfregion, muss der Flap durch den Ambulanzzarzt VOR dem Planungs-CT aufgelegt werden. Bei Basaliom Nasen-/Ohrregion bitte statt Flap Planungs-CT mit Moulage.)

Lagerung:

☒ Bauchlage	☐ Belly step
☐ Rückenlage	☐ Pro step
☒ Arme: oben	☐ Knee step
☐ Maske: Netz IMRT HyperArc	☐ Schultermarker
☐ Nackenschale	☐ Blasenfüllung:
☐ Wing step	☒ Ausmarkierung
☐ Knierolle	☐ Drahtmarkierung:
☐ Bluebag	☐ Vaginaltampon
☐ Zahnschienen	☐ Kopfschale

Datum: 23.09.2025

erstellender Arzt: Dr. Jonas Berger

Datum: 23.09.2025

F-/O-Arzt: Dr. Lara Steiner

Fiktive Patientendaten - ausschließlich für Ausbildung/Simulation Patient/in: Manfred Leitner geb.: 11.11.1958 ID: ST-REK-2025-02
FALL-ID: FALL-REKTUM-BL-02

Datum der Untersuchung: 02.10.2025

Gewicht Patient: ca. 66 kg

Ganzkörper-CT: ☐ Patientendurchmesser < 30 cm
☐ Patientendurchmesser > 30 cm (Probeliegen bei Erstgespräch)

Referenzpunkt: Becken/Perinealreferenz

Tischhöhe: 13 cm

LAGERUNG:

☒ Bauchlage	☐ Belly step: A B C
☐ Rückenlage	☐ Pro step
☒ Arme: oben	☐ Knee step
☐ Maske: Netz IMRT HyperArc	☐ Schultermarker
☐ Nackenschale	☐ Blasenfüllung:
☐ Wing step; Ring: ja nein	☒ Ausmarkierung
☐ Knierolle	☐ Drahtmarkierung:
☐ Bluebag	☐ Vaginaltampon
☐ Flap/Moulage	☐ Kopfschale
☐ Zahnschienen: oben unten	☐ blaue Matte
☐ Bauchpresse P1 P2 S M L XL	
☐ schiefe Ebene	
☐ DIBH	☐ 4D-Atemstudie
☐ Name Atemkurve:	

Rektum-CT in Bauchlage. Anal-/Tumorregion ausmarkiert; Vorbereitung und Lagekomfort prüfen.

Nach Durchführung der CT verpflichtende Kontrolle (DA)**kontrolliert:**

- | | |
|---|-------------------------------------|
| 1. Wirbelsäule optisch und im Scout gerade gelagert?
Keine metallischen Lagerungshilfen im Bild? | ☒ |
| 2. Ref.-markierung (Bleikugeln) im CT-Schnitt auf einer Schicht? | ☒ |
| 3. Blasen-/Rektumfüllung kontrolliert? | ☐ |
| 4. KM-Reste Darm/Blase -> Arzt dazu | ☐ |
| 5. Ganzer Patientenumfang wird rekonstruiert? | ☒ |
| 6. Bei Kontroll-CT: Was wurde mit Bleikugeln markiert? | ☐ |

Datum: 02.10.2025 13:24

MTRA: J. Fuchs

Datum: 02.10.2025 13:45

F-/O-Arzt: Dr. Felix Brandt